جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صافيناز شحاتة رؤوف ملطى

المحافظة : المنيا **الحي / المدينة :** مغاغه **العنوان :** عزبة فكرى مغاغة المنيا

رقم البطاقة : 28506142400665 **رقم التليفون :** 01227273137 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 14-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 14-06-1985 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(--------------------------)

المقر بما فيه
التوقيع:(--------------------------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : --------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** د/ محمد كيلاني

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** ندى حسن

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** -------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان

G R I - E
جوستاف روسي
جوستاف روسي مصر

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ----------------------- **ا.د/** ----------------------- **د/** ----------------------- **د/** -----------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --
خطة العلاج : --
المستشفي : -- **قسم :** --
جهة العلاج : -- **نفقات :** --
ملاحظات : --

رئيس المجلس الطبي المتخصص	**مدير عام مديرية الشئون الصحية**	**ختم شعار الجمهورية**

Name: صافيناز شحاتة رؤوف ملطي
National ID: 28506142400665

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

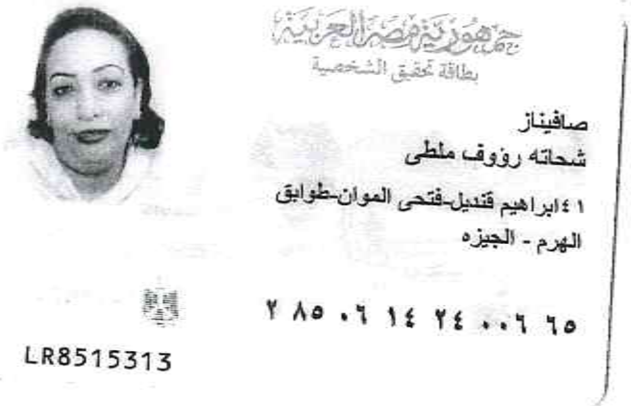
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bone scintigraphy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

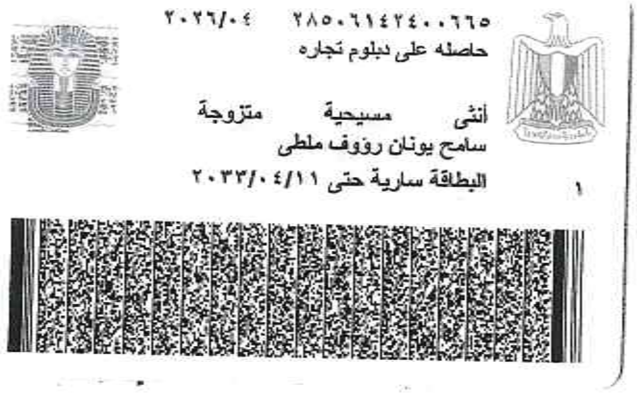


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

صافيناز
شحاته رؤوف ملطى
٤١ ابراهيم قنديل-فتحى الموان-طوابق
الهرم - الجيزه

٢ ٨٥ ٠٦ ١٤ ٢٤ ٠٠٦ ٦٥

LR8515313



٢٨٥٠٦١٤٢٤٠٠٦٦٥ ٢٠٢٦/٠٤
حاصله على دبلوم تجاره

أنثى مسيحية متزوجة
سامح يونان رؤوف ملطى
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٤/١١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

٤٢٨٢

جوستاف روسي
انترناشونال
مصر

Medical No. : 9577
Patient's Name: **Safinaz Shehata Raouf Maltai**
Date: **2026-10-03**
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: **Goustave Roussey International Egypt**

Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Post left MRM & ALAND, routine follow up.

Findings:

Right breast.

- Heterogenously dense breast . (ACR c)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes
-

Conclusion:-

- ***Right breast (BIRADS 1): normal study.***
- ***Clear left mastectomy bed and axilla.***

Recommendation:-

- ***For annual follow up.***

Best Regards,
DR. Dina SAYED , M.Sc.CUDBIT

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routing screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignant	

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Medical No. : 9577
Patient's Name: Safinaz Shehata Raouf Maltai
Date: 2026-10-03
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

جوستاف روسي
انترناشونال

MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST WITHOUT CONTRAST REVEALED:-

Known case of breast CA underwent left MRM.

- Left upper lobe subpleural reticulations and ground glass densities likely post radiation sequelae.
- No pulmonary nodules, masses, consolidation, collapse or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial effusion.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Intact bony thoracic cage.

Opinion:-

- **No pulmonary metastatic lesions.**

Dr.sherif Wagdy

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]

Patient's Name: Safenaz Shehata
Date: **2026-10-3**
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: **Goustave Roussey International Egypt**

Pelvi-abdominal ultrasonographic examination, revealed:

- The liver is not enlarged measuring about 16 cm with homogeneous echo-pattern. No definite focal lesions or IHBRD by US criteria.
- Patent portal vein with average diameter showing normal flow direction.
- Gall bladder is averagely dilated with normal wall thickness. No stones mud seen. Non-dilated CBD.
- Spleen is not enlarged measuring about 10 cm with homogenous echo pattern and no definite focal lesions.
- The midline structures and visualized portions of the pancreatic head are free.
- Colonic gaseous distension.
- Both kidneys are average in size, shape, echo-pattern and differentiation. No backpressure changes.
- No ascites at time of examination.
- Average filling of the urinary bladder with no stones or masses.
- Normal size of the uterus with no definitive focal lesion.
- No gross adnexal lesion.
- No pelvic fluid collection.

Conclusion:

- Colonic gaseous distension.
- Otherwise, unremarkable study.

Best regards;
Dr. Mohammad Islam

03/10/25 1:37:28 PM

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

إسم المريض ثلاثي: ....

رقم الملف: ....

تقريــر طبــي

السيد/..

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من .... بشان تقرير طبي للمريض: صافيناز شحاته

بقسم.................رقم طبي ....

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول.......... ....تاريخ وساعة الخروج...........................

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

تشتكي المريضة من ورم خبيث بالثدي

واجريت العلاج الجراحي من استئصال كلي

وتلقت العلاج الكيماوي والاشعاعي

ومازالت تتلقى العلاج الهرموني

والمتابعة الدورية بالمركز

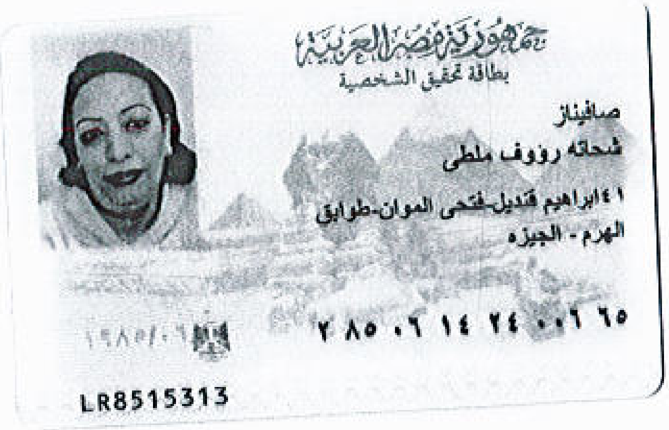
تحريرا في

الوقت: .... التاريخ: ١٢/١٠/٢٠٢٦

الطبيب المعالج

د. ....

يعتمد ،،



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

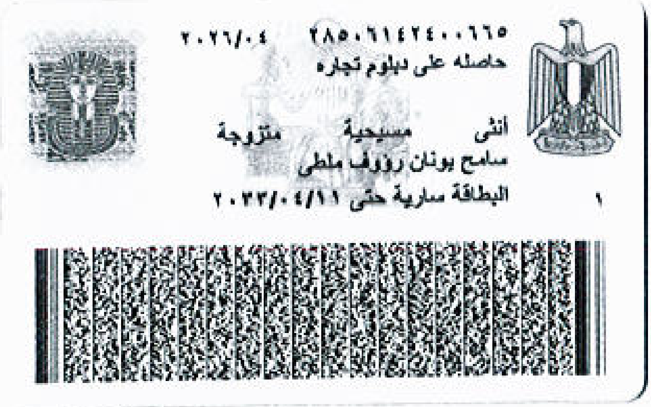
صافيناز
شحاته رؤوف ملطى
٤١ ابراهيم قنديل-فتحى الموان-طوابق
الهرم - الجيزه

٢٨٥٠٦١٤٢٤٠٠٦٦٥

١٩٨٥/٠٦

LR8515313

DMS
أوراق ١٤/١ ابراهيم
شعبيا



٢٨٥٠٦١٤٢٤٠٠٦٦٥ ٢٠٢٦/٠٤
حاصله على دبلوم تجاره

انثى مسيحية متزوجة
سامح يونان رؤوف ملطى
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٤/١١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جوستاف روسي
انترناشونال
مصر

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية
هي
صحة
مصر

MDT FORM

14/9/2025 G

Name	حواهيار سناء دروش	**MRN**	C009 / C CE
		ID	٢٨٥٠٦١٤٤٤٠٢٦٥
Age	39 Y.	**Phone**	01227273137
Menopausal status	Pre-P	**Marital status**	
NRS SCORE		**Family history**	
BMI		**REASON OF MDT**	
CO morbidity			

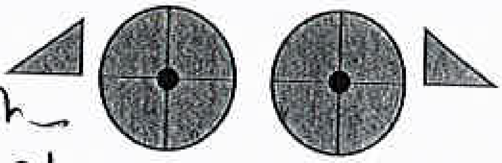
MDT

Clinical Data

BX: IDC III

ER: +ve 6/8	**PR:** +ve 5/8	**HER 2:** -ve	**Ki67:** 45%

R L



TNM

Sonomammography: Pre-P left Breast
LT MRM on 29/8/2025

Mets Workup: pT3, N1 2/30, M0
Rec adj 4 AC, 12 weeks
ST Zoladex c Nolvadex f 3/2026

Recommendations: pt is high risk T3, N1 grade 3
Age < 40 c̄ adj
fr. MDT (for possibility to shift to AI + Zoladex)
– ٥/٩/١١ [illegible]

MDT OUTCOME & PLAN

AI + Zoladex X 7 years
(Arimidex)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذه / [illegible] شحاته رؤوف ملطى
Patient No. : 28506142400665
Path No. : 3144/24
Sex : Female
Age : 39 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13005832
Request Date : 29/08/2024
Verification Date : 16/09/2024
Financial Category : [illegible] - مبادرة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Up-Front
Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:
* Procedure: Left MRM measured 26x18x7 cm with covering skin ellipse measured 23x18 cm.
* Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
* Size: 8 x4.5 x4 cm.
* Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
* Distance from margins: 1 cm away from deep margin.
* Lymph nodes number and size: 30 L.Ns up to 2.5x2.5cm.
* Also detected two intra- mammary lymph nodes 1.5x1.5 and 1x1 cm.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Focal (high grade).
* Skin involvement: Free nipple and areola.
* Lymph node involvement: Positive in (2/30) axillary lymph nodes and Negative (0/2) intra-mammary lymph nodes.
Total nodal status (2/32) lymph nodes.
* Resection Margins: Free deep margin.

Diagnosis:
Left breast cancer Up-Front, MRM specimen:
Invasive duct carcinom, Grade II with focal DCIS.
Free deep margin.
Free nipple and areola.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذه / صافيناز شحاته رووف ملطى
Patient No. : 28506142400665
Path No. : 2455/24
Sex : Female
Age : 39 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13003875
Request Date : 17/07/2024
Verification Date : 23/07/2024
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Deparlment : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast malignant looking solid mass lesion.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 16/7/2024.

Gross Examination:
- Four grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Focally necrotizing, Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+3) Grade III.
* Ductal carcinoma in situ: Focally positive.
* Perineural invasion: Negative.
* Angioinvasion: Negative.
* Microcalcifications: Positive.

Diagnosis:
Left breast malignant looking solid mass lesion, Tru-cut biopsy:
Focally necrotizing invasive duct carcinoma, Grade III, with focal DCIS and microcalcifications.
For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Menna Nabil.

[illegible]
٢٨/٧/٢٠٢٤

Verified by :

CAP

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name : الأستاذه / صافيناز شحته رؤوف ملطى
Patient No. : 28506142400665
Path No. : 2455/24
Sex : Female
Age : 39 Y
Referreing Doc. :

Request No. : 13003875
Request Date : 17/07/2024
Verification Date : 04/08/2024
Financial Category : [illegible]
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast malignant looking solid mass lesion.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 16/7/2024.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
- IPT (Positive control showed appropriate reactivity)
- ER: Strong nuclear reaction in 13% of tumor cells (score 6 /8).
- PR: Strong nuclear reaction in 9% of tumor cells (score 5 /8).
- Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
- Ki67: 45% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:
Left breast malignant looking solid mass lesion, Tru-cut biopsy:
Focally necrotizing invasive duct carcinoma, Grade III, with focal DCIS and microcalcifications.
IPT:
- ER: Positive (score 6 /8).
- PR: Positive (score 5 /8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 45% of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"

Verified by :

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
مبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	الأستاذة / [illegible] شحاته رؤوف متى	Request No.	13003875
Patient No.	28506142400665	Request Date	17/07/2024
Path No.	2455/24	Verification Date	04/08/2024
Sex	Female	Financial Category	أورام دار السلام - مبادرة
Age	39 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 20[illegible]IHC 0; as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete. Intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Toqa Medhat

Verified by

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

BAHEYA
Radiology Department

بهية
قسم الأشعة التشخيصية

PATIENT NAME: SAFENAZ SHEHATA RAOUF MALTY
GENDER: Female
DATE : 25-Aug-2024 01:52 PM

PATIENT ID: 10124248074
AGE: 39 y
ORDER: 3004434

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:
Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report:

No hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.
Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.
Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Prof. Huda Fathy, Nuclear Medicine Consultant **25-Aug-2024 01:19 PM**

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Patient Name	: الأستاذة / صافيناز شحته رؤوف مطلى	Request No.	: 13005832
Patient No.	: 28506142400665	Request Date	: 29/08/2024
Path No.	: 3144/24	Verification Date	: 16/09/2024
Sex	: Fomale	Financial Category	: [illegible]
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Positive in (2/30) of lymph nodes, Negative (0/2) intra-mammary lymph nodes.
Total nodal status (2/32) lymph nodes..
Stage: pT3, pN1.

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Sagda Elkady.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذة / صافيناز شحاته رؤوف ملطى
Patient No. : 28506142400665
Path No. : 2455/24
Sex : Female
Age : 39 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13003875
Request Date : 17/07/2024
Verification Date : 23/07/2024
Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast malignant looking solid mass lesion.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 16/7/2024.

Gross Examination:
- Four grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Focally necrotizing, Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+3) Grade III.
* Ductal carcinoma in situ: Focally positive.
* Perineural invasion: Negative.
* Angioinvasion: Negative.
* Microcalcifications: Positive.

Diagnosis:
Left breast malignant looking solid mass lesion, Tru-cut biopsy:
Focally necrotizing invasive duct carcinoma, Grade III, with focal DCIS and microcalcifications.
For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Menna Nabil.

[illegible]

Verified by :

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]